



TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

Historia Zk. / Nº Historia **IKK** / CIC **Gizarte Segurantz Zk.** / Nº Seguridad Social **Jaiotze Data** / F. Nacimiento
536665 **1164816** **10015586764** **15/05/1956**

Gertakari Zk. / Nº Episodio **Sarrera Data** / F. Ingreso **Alta Data** / F. Alta **Zerbitzu** / Servicio
2558849 **09/06/2020 09:27** **09/06/2020 12:33** **URGENCIAS GENERALES**

Profesional / Profesional
BOTÍN GÓMEZ, ALBERTO

Varon de 64 años que acude por CEFALEA ESPONTÁNEA NO TRAUMÁTICA

ANTECEDENTES PERSONALES:

- Sin alergia medicamentosas conocidas.
- HTA y dislipemia en tratamiento farmacológico.
- Primer episodio de FA, revertida con Vernakalant en octubre 2019. Posterior control en CCEE de Cardiología; ecocardiograma en nov/2019 con FE conservada, AI dilatada ligera. Dado de alta en abril/2020.
- Accidente de bicicleta en el año 2003: TCE grave con fractura de base craneal y fractura temporal izquierda. Hematoma epidural temporal izquierdo. Hematoma subdural temporo-parietal izquierdo. Hemorragia subaracnoidea traumática. Importante desviación de línea media con borramiento de cisternas basales. Preciso tratamiento de rehabilitación por presentar una afasia mixta de predominio motor. Discreta hemiparesia derecha.
- Epilepsia. Última crisis en 2010, generalizada tónico clónicas.
- Fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018. En control por neuroradiología. Ingresa en junio/19 para control angiográfico con resultado de correcta embolización.
- Antecedentes quirúrgicos: Varices (Dic 2017). Sutura tendón mano 2017 con AG, evacuación de hematoma subdural y epidural y craneotomía descompresiva por TCE grave en 2003. Fractura humero

- Tratamiento habitual (actual):

EDOXABAN 60 MG 24 HORAS
ATENOLOL 100MG DESAYUNO
FELODIPINO 5MG DESAYUNO
SIMVASTATINA 20MG ACOSTARSE
LAMOTRIGINA 100MG DESAYUNO Y CENA
LORAZEPAM 1MG ACOSTARSE

ENFERMEDAD ACTUAL:

Refiere desde hace 1 semana tinnitus pulsátil clínica que le recuerda a episodio de Fístula arteriovenosa dural

FIRMADO:

010103550 BOTÍN GÓMEZ, ALBERTO

FECHA INFORME: 09/06/2020

HORA INFORME: 13:08

PÁGINA: 1 / 5



Osakidetza

TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO

Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA

Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A

1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

del seno sigmoide d2018

No cefalea no otra focalidad neurologica . No fiebre no tos no flemas , no dolor toracico

EXPLORACION GENERAL:

Bien nutrido e hidratado. Buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en reposo.

- Constantes vitales:

- Temperatura: 36.3 °C.
- Tensión Arterial: 134/82 mmHg.
- Pulso: 65 p.p.m.
- Frecuencia respiratoria: 14 r.p.m.
- Pulsioximetría: 97 %.

- Cabeza y cuello: . No IY.

- A.C.: Rítmica. No soplos, roces ni extratonos.

- A.P.: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

- Abdomen: Blando y depresible. No doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal. No masas ni visceromegalias. Peristaltismo conservado. No soplos abdominales. Puño-percusión renal bilateral negativa.

- EE.II.: No edemas. No semiología de TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA:

- Consciente, orientado temporo-espacialmente y colaborador.

- Pupilas isocóricas y normorreactivas.

- Escala de Glasgow: 15/15.

- No rigidez de nuca. Kerning y Brudzinsky negativos.

- No claudicación de extremidades ni otros déficits motores.

- Reflejos osteotendinosos conservados.

- Reflejo cutaneo-plantar en flexión bilateral.

- No disimetrías en las pruebas dedo-nariz y talón-rodilla.

- No déficits en la sensibilidad superficial

- Pares craneales:

- MOE normales. No nistagmus.
- Facial: No paresias.
- Campimetría por confrontación normal.
- Resto de pares normal.

- Romberg: negativo.

- Marcha en tándem normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

ECG RS a 60 LM sin alteraciones d el arepolarización

FIRMADO:

010103550 BOTÍN GÓMEZ, ALBERTO

FECHA INFORME: 09/06/2020

HORA INFORME: 13:08

PÁGINA: 2 / 5



TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

BIOQUIMICA GENERAL

BIOQUIMICA SUERO

Srm-Glucosa	103 mg/dL	60 - 110
Srm-Urea	26 mg/dL	10 - 50
Srm-Creatinina	0,97 mg/dL	0,5 - 1,4
Srm-Sodio	138 mEq/L	135 - 146
Srm-Potasio	4,3 mEq/L	3,5 - 5,5
Srm-Cloruro	105 mEq/L	95 - 110
Srm-Proteina C reactiva (PCR)	1,5 mg/L	0,00 - 5,00

HEMATOLOGIA GENERAL

San-Hemograma

San-Hematíes	5,18 *10 ⁶ /μL	4,5 - 5,9
San-Hemoglobina	16,6 g/dL	13 - 17,7
San-Hematocrito	49,7 %	40 - 53
San-Volumen corpuscular medio (VCM)	95,9 fL	78 - 101
San-Amplitud de distribucion eritrocitaria		

(ADE) 11,6 % 11,5 - 14,5

San-Hemoglobina corpuscular media eritrocitaria

(HCM) 32,1 pg 27 - 33

San-Concentración de hemoglobina corpuscular

media 33,4 g/dL 30,5 - 35,5

San-Plaquetas	201 *10 ³ /μL	100 - 450
San-Volumen medio plaquetario	* 6,8 fL	7,4 - 11
San-Leucocitos	4,78 *10 ³ /μL	4 - 11

San-Formula leucocitaria

San-Neutrófilos	57,90 %	30 - 70
San-Linfocitos	27,60 %	25 - 50
San-Monocitos	12,60 %	0 - 25
San-Eosinófilos	0,80 %	0 - 5
San-Basófilos	* 1,06 %	0 - 1
San-Neutrófilos	2,77 *10 ³ /μL	1,5 - 7,7
San-Linfocitos	1,32 *10 ³ /μL	1,1 - 4,5
San-Monocitos	0,60 *10 ³ /μL	0,1 - 1,0
San-Eosinófilos	0,04 *10 ³ /μL	0 - 0,5
San-Basófilos	0,05 *10 ³ /μL	0,0 - 0,2

HEMOSTASIA

Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada

(TTPA) 38 sg 0 - 40

Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada

(TTPA)(ratio) 1,21 0,00 - 1,30

FIRMADO:

010103550 BOTÍN GÓMEZ, ALBERTO

FECHA INFORME: 09/06/2020

HORA INFORME: 13:08

PÁGINA: 3 / 5



Osakidetza

TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

Pla-Tiempo de protrombina (sg)	12,50 sg	
Pla-Tiempo (Indice) de protrombina (%)	91 %	70 - 150
Pla-INR (Ratio Internacional Normalizada)	1,1	0,8 - 1,2
Pla-Fibrinogeno (derivado)	467 mg/dL	150 - 500

Comentario:

Se realiza TC craneal urgente sin CIV.

No signos de sangrado intra ni extraaxiales.

Cambios postquirúrgicos secundarios a craniectomía frontotemporal izquierda, allá y áreas gliótico malácicas de localización frontotemporales izquierdas que condiciona tracción de surcos adyacentes y VL izquierdo

Línea media centrada

Cuarto ventrículo sin alteraciones

Material de embolización a nivel del seno sigmoideo izquierdo que condiciona artefacto metálico que dificulta la valoración de fosa posterior

Estado del informe VALIDADO / Doctor/a HERNANDEZ SASTRE, IGNACIO

EVOLUCION :

paciente sin focalidad neurologica , comentado con neurocirujana de guardia Dra . Silva se decide alta y cita en consultas externas (le llaman)

IMPRESION DIAGNOSTICA :

tinnitus pulsatil en paciente Fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho

TRATAMIENTO DE ALTA:

FIRMADO:

010103550 BOTÍN GÓMEZ, ALBERTO

FECHA INFORME: 09/06/2020

HORA INFORME: 13:08

PÁGINA: 4 / 5

15

 Osakidetza TXAGORRITXU OSPITALEA H. TXAGORRITXU	GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO <i>Deiturak / Apellidos</i> LUIS MARIA <i>Izena / Nombre</i> TOMAS ALFARO, 0013 007 A 1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA) <i>Helbidea / Dirección</i>
URGENCIA	
URGENCIAS DE MEDICINA	

Si empeoramiento acudir a urgencias

010103550 BOTÍN GÓMEZ, ALBERTO	FIRMADO:	FECHA INFORME: 09/06/2020
		HORA INFORME: 13:08
		PÁGINA: 5 / 5
		15

